

إِسْمُ الْمَرِيضِ رُبَاعِيًّا : نَعْمَهُ صَبَحَى سَعِيدَ عَوْضَ

المحافظة : البحيرة

الحي / المدينة : ابوالمطامير

العنوان : 000

رقم البطاقة : 28612272601829 رقم التليفون : 01273308699

تاريخ تسجيل الإستمارة : 29-09-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 27-12-1986 المهنة : حاصل على دبلوم

المهنة : حاصل علي دبلوم

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (_____)

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157]

الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157]

التعليق على التشخيص : -----

GR1-E
جورستان
روستای پل
لندی
موسین
صحة الايادي
للحنة و مدن

الاسم: د/محمد کیلانی

الوظيفة: ----- التوقيع:

الاسم: د/ندی حسن

الوظيفة: _____ التوقيع: _____

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم حمة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / 2 ----- / 2 ----- / 2.1 ----- / 2.1

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج :-

ملاحظات : ---

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

ختم

شعار الجمهورية

Name: نعمة صبحي سعيد عوض
National ID: 28612272601829



تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ وساعة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ وساعة الدخول :
-- --:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy

الوقت :

-- --:--

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

نعمه
صبحى سعيد عوض
كوم الفرج
مركز ابو المطاير - البحيرة

١٩٨٦/١/٢٧ ٢٨٦ ١٢ ٢٧ ٢٦ ٠١٨ ٢٩

JA5293303

٢٠٢١/٠٩ ٢٨٦ ١٢ ٢٧ ٢٦ ٠١٨ ٢٩

دبلوم صناعى

أنثى
مستحقة
رومانى كامل أمين جرجس
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٩/٢٥

٩

مركز الأورام
NASSER INSTITUTE
ONCOLOGY CENTER

معهد ناصر
مركز الأورام



NUCLEAR MEDICINE UNIT

وحدة الطب النووي

Patient Name: Naema Sobhy
Referring physician: Prof.

Date: 10/12/2020

^{99m}Tc -MDP BONE SCAN

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc -MDP:

Report:

- No definite hot spot that account for osseous deposits could be detected all over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are noted in the dorso-lumbar vertebrae.
- Both kidneys are normally seen

Conclusion:

No definite evidence of metastatic osseous deposits.
Thanks for reference

Nuclear Medicine Unit

Magdy Kotb, M.D.

Name: نعمه صبحى سعيد عوض		
MR. : 7946		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحيه طيبة وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient presents with a diagnosis of breast cancer and is currently receiving an aromatase inhibitor therapy with Zoladex. The patient has been on this AI regimen for three months, and the Zoladex implant is pending.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	21-09-2026
	الوقت :	
	nada mohamed elsayed	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



Part OP

وزارة الصحة والشؤون
المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
هرمل، سابقا

01227784917

Name: نهة سبيح

Age: 34 y

No.:

ID/071CCV9.1A9

MDT FORM

MRM: 17/5/2021

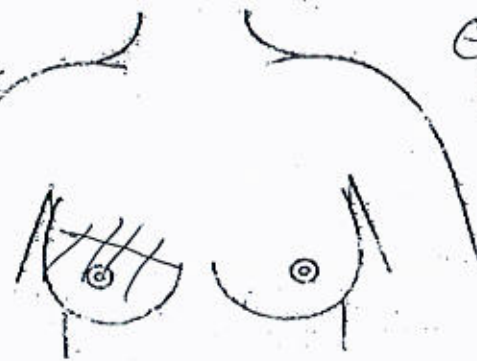
Clinical data

YPT N1

Type: Multi Centeric IDC
grade II, post NACT

Margins: free

Axillary LN: -ve (2/11)



Barbie
ER S/B
PR 4/8
Herz (+)

Received 2 cycles Herceptin
+ 4 EC, 12 Taxol

Reason of discussion:

For adjuvant therapy

MDT Outcome and Plan

12/6/2021 => Adjuvant TDM (1y) (No PCR)
Zoladex + A.I (Sys then consider
extende
PORT

Signature:

MD/10/10

[Signature]



Pathology Report

Name: نعمة صبحى

Age: 33 years.

Clinical data: Right breast mass.

Specimen type: Tru cut biopsy.

Date: 14/11/2019

Lab. Number: 1200

Hospital Number: 4486/2019

Gross Description:

Three partly fragmented greyish to brown tissue cores, the longest was; 1.2 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:

Histopathological examination of section prepared revealed cores of malignant growth, formed of clusters and tubules of moderately differentiated ductal epithelial cells in a fair desmoplastic stroma.

Diagnosis:

Right breast mass, core biopsy;

Invasive duct carcinoma GII, for IHC; (ER, PR, Her2 & Ki67).

Prof. Dr. Lubna Omar

Prof. Dr. Essam Ayad



ImmunohistoChemistry report

Report Number: m6997

Female	النوع	نعمة صبحي سعيد	اسم المريض
القاهرة	العنوان	33 Y	السن
24/11/2019 12:41	تاريخ استلام العينة		تاريخ اخذ العينة
11/12/2019 13:02	تاريخ التقرير	مركز اورام دار السلام	طالب التحليل
		مركز اورام دار السلام	عناية

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER & PR & HER2 neu (ER&PR : Harvey scoring system - Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by: - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody.- CONFIRM anti-progesterone receptor(PR) (IE2)Rabbit monoclonal primary antibody.

Sample recieved was treated by: -VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX.

Result :

ER: moderate nuclear staining of 30 % of tumour cells

PR: moderate nuclear staining of 10 % of tumour cells

HER2/neu protein over expression : strong continuous membrane staining of > 10 % of tumor cells.

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 5 / 8)

PR: POSITIVE (SCORE 4 / 8)

HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : POSITIVE (SCORE 3+) (TINY CORE)

Pathologist: د/أيمن رمزي

Lab Director: د/تريزا ماهر



Prof. Dr. Alaa Abd El Hamed
Prof. Dr. Hassan Khamis
Prof. Dr. Osama El Abd
Dr. Hany Ebada
Dr. Hamdy Hassan



أ.د. / علاء عبد الحميد
أ.د. / حسن خميس
أ.د. / أسامة العبد
د. / هاني عبادة
د. / حمدي حسن

Patient Name: Nema Sobhy Saeid Awad	Age: 34 Years
Sex: F	ref. by: Dear Colleague
Study Date: 12/11/2020 11:54:10 ص	procedure: CT chest, Abdomen&Pelvis

REPORT

Clinical data: known patient with given history of pathologically proved right breast multi-focal infiltrating duct carcinoma with axillary nodal deposits managed by chemotherapy sessions; no definite previous relevant DICOM data for comparison; however the current study revealed:

Chest:

- Few bilateral basal atelectatic plates on background of mosaic attenuation pattern.
- Otherwise clear both lungs field; no parenchymal lesions identified.
- Normal mediastinal vascular structures.
- Normal CT features of trachea, main stem bronchi as well as their lobar and segmental divisions.
- Normal pleural reflections; no pleural collections.
- No mediastinal lesions identified.
- No mediastinal nor hilar lymphadenopathy identified.
- Right breast few ill-defined soft tissue densities are seen, with rather defined lesion noted at the inner lower quadrant associated with mild overlying skin thickening ... To be correlated with previous sonomammographic data.
- Few bilateral axillary morphologically reactive lymph nodes are seen with preserved fatty hilae.

Abdomen:

- The liver is of normal size, and tissue density. It shows no focal or enhancing lesions.
- The intra and extra-hepatic biliary radicles are normal.
- The pancreas is of normal matrix; no calcifications or focal lesions identified. No pancreatic duct dilatation.
- The spleen is of normal size and tissue characters. No focal lesions identified.
- Both kidneys are normal in size, shape and position. No renal stones, expanding lesions or back pressure changes identified.
- Right and left supra renal glands are normal.
- The retrocrural, para-aortic abdominal and pelvic lymph nodes are normal.
- No ascites.
- Small para umbilical fatty hernia.
- Scans through pelvis show normal appearance of pelvic organs.
- Mild sigmoid colon extra looping.
- LV5 pars defects with no static instability.

Kindest regards

Prof. Dr. Osama El Abd, MD.

Dr. Mohamed Ibrahim, MD.

كفر الدوار المدخل الجديد - برج قصر الأمراء ت ٢١٧٧٢٢٤ - ٢١٧٧٢٢٣ - ٢١٤٤٨٨٣ - ٢١٤٤٨٨٢ (٠٤٥)
كفر الدوار - ش بورسعيد (البحر) - برج الزهراء - أعلى صيدلية د/ إسلام عامر ت ٢١٧٧٧٠٠ - ٢١٣١٩٦٥ - ٢١٣١٩٦٤ (٠٤٥)



Patient Name: Ne'ma Sobhy Saeed Awad	Date : 23/01/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 38 Year(s)
Medical ID: 4486/2019	Pat. ID: 28426

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had right MRM in

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- The left breast is heterogeneously dense which may obscure small lesions (ACR C),
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no left breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Right MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No right breast suspicious findings (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. basma mohmaed

23/01/2025 2:07 PM